

Bronchiectasis Unlocked

UMFRAGE FÜR TEILNEHMENDE DES EXPERTENFORUMS

Diese kurze Umfrage soll reale Versorgungsmuster bei Bronchiektasen-Erkrankung erfassen – einschließlich Patient:innen-Charakteristika, Behandlungsansätzen und der Wahrnehmung der deutschen S2K Leitlinie. Bitte wählen Sie die Antwortoption(en), die Ihre Praxis am besten beschreiben.

Bitte tragen Sie hier Ihren Titel, Vornamen und Namen ein:



Insmmed Germany GmbH
The Squire 12, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main

Abschnitt 1 – Ihre Praxis & Ihr Patient:innenkollektiv

1. Geschätzte Anzahl an Patient:innen mit Bronchiektasen-Erkrankung in Ihrer Praxis

< 10 10 – 30 31 – 50 > 50

2. Anteil der Patient:innen mit Bronchiektasen-Erkrankung mit folgenden Komorbiditäten/ Ätiologien (Mehrfachauswahl möglich; bitte ungefähren %-Anteil angeben)

Komorbiditäten

COPD %

Asthma %

NTM-Infektion %

Mukoviszidose %

Sonstiges: – %

Keine / nicht erhoben

Ätiologien

idiopathisch %

COPD %

Asthma %

NTM-Infektion %

Mukoviszidose %

Sonstige: – %

3. Welche Faktoren definieren Ihrer Meinung nach am ehesten „Hochrisiko-Patient:innen“ mit Bronchiektasen-Erkrankung? (Mehrfachauswahl)

≥ 2 Exazerbationen pro Jahr	Progredienter Verlauf
Hospitalisierung innerhalb der letzten 12 Monate	Hohe Symptombelastung / reduzierte Lebensqualität
Chronische Infektion/Kolonisation (z. B. P. aeruginosa)	Häufiger Antibiotikabedarf
Niedriger FEV ₁ / eingeschränkte Lungenfunktion	Sonstiges:

4. Wie hoch ist der Anteil ihrer Patient:innen mit Bronchiektasen-Erkrankung mit 0, 1, 2, oder > 2 Exazerbationen innerhalb der letzten 12 Monate? (bitte ungefähren %-Anteil angeben)

0: % 1: % 2: % > 2: %

ABSCHNITT 2 – Diagnose

5. Wer stellt typischerweise die Diagnose „Bronchiektasen-Erkrankung“?

Pneumolog:in (niedergelassen)

Fachärzt:in im Universitäts- / Referenzzentrum

Fachärzt:in im Krankenhaus

Gemeinsam / interdisziplinär

6. Welche diagnostischen Maßnahmen sind in Ihrer Einrichtung Routine? (max. 3 auswählen)

Sputumkultur / Mikrobiologie

Blutuntersuchungen / Biomarker

Lungenfunktion (Spirometrie)

Sonstiges:

Pulsoximetrie / kapilläre Blutgasanalyse

FeNO

ABSCHNITT 3 – Behandlungs- & Versorgungsmuster

7. Welche langfristigen Behandlungsansätze sind bei Ihren Patient:innen mit Bronchiektasen-Erkrankung am häufigsten? (max. 3 auswählen)

Atemphysiotherapie

ICS

chronische Makrolidtherapie bei
≥ 2 Exazerbationen/Jahr

Impfungen

Mukolytika/Sekretolytika

Rehabilitation

Inhalative Antibiotika

Sonstiges:

Bronchodilatoren (LABA/LAMA)

8. Welche Hauptprioritäten und -ziele verfolgen Sie bei der Behandlung der Bronchiektasen-Erkrankung? (max. 3 auswählen)

Optimierung der Atemwegs-/Sekret-
Clearance

Vermeidung von Hospitalisierungen

Kontrolle / Prävention von Infektionen

Management von Komorbiditäten
(COPD, Asthma, etc.)

Reduktion von Exazerbationen

Minimierung von Antibiotikagebrauch

Verbesserung von Lebensqualität

Sonstiges:

Erhalt der Lungenfunktion

9. Was sehen Sie als wichtigsten ungedeckten Bedarf in der aktuellen Versorgung der Bronchiektasen-Erkrankung? (eine Antwort)

Frühere Identifizierung von Hochrisiko-Patient:innen

Bessere Optionen zur Reduktion oder Vermeidung von Exazerbationen

Therapien, die gezielt die Entzündung in den Atemwegen adressieren

Verbessertes Management chronischer Infektionen

Bessere Adhärenzunterstützung

Sonstiges:

10. Wie überwachen Sie das Therapieansprechen bei Patient:innen mit Bronchiektasen-Erkrankung? (Mehrfachauswahl möglich)

Regelmäßige Lungenfunktion (z. B. Spirometrie / FEV₁)

Wiederholte Sputumkulturen / Mikrobiologie

HRCT

Symptom- oder Lebensqualitätsbewertung bei jedem Besuch

Erfassung von Exazerbationsfrequenz oder -schwere

Überprüfung der Physiotherapie-Technik

Überprüfung der Adhärenz

Nach-Exazerbations-Reevaluation der Therapie

Sonstiges:

11. Wie hoch ist die Besuchsfrequenz pro Jahr von Patient:innen mit Bronchiektasen-Erkrankung mit 2 oder mehr Exazerbationen in den letzten 12 Monaten ?

1 – 2

3 – 4

5 – 6

> 6

12. Wie hoch schätzen Sie den Anteil an Exazerbationen, welche Ihnen von Ihren Patient:innen nicht gemeldet werden?

0 %

0 – 25 %

26 – 50 %

51 – 75 %

> 75 %

ABSCHNITT 4 – Zusammenarbeit & Unterstützungsbedarf

13. Wie erfolgt die interdisziplinäre Zusammenarbeit (MDT) in Ihrer Einrichtung? (Mehrfachauswahl möglich)

Regelmäßige MDT-Meetings (geplante Fallbesprechungen)

Ad-hoc-Konsultationen mit anderen Fachrichtungen

Gemeinsame elektronische Patient:innenakte oder Kommunikationsplattform

Zentraler Versorgungspfad mit definierten Rollen

Informelle Kommunikation (Telefon/E-Mail)

Keine strukturierte Zusammenarbeit

Sonstiges:

Abschnitt 5 – die deutsche S2k-Leitlinie 2024

14. Wie nehmen Sie die deutsche S2k-Leitlinie 2024 „Management erwachsener Patientinnen und Patienten mit Bronchiektasen-Erkrankung“ wahr, und welchen Einfluss hat sie auf Ihre Praxis?

Sie bringt wichtige neue Aspekte, die mein Management verändert haben

Sie bestätigt weitgehend mein bisheriges Vorgehen und liefert hilfreiche Klarstellungen

Sie ist nützlich, aber die praktische Umsetzung im Alltag ist herausfordernd

Ich bin mit der Leitlinie nicht vertraut

Optionaler Kommentar:

Welche Teile der Leitlinie empfinden Sie als besonders relevant oder herausfordernd?

Ende der Umfrage – vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Bronchiectasis Unlocked

BRONCHIEKTASEN-ERKRANKUNG ENTSCHLÜSSELN – IHR PRAXISFALL IM FOKUS

Welcher Ihrer Fälle der Bronchiectasen-Erkrankung hat Sie in letzter Zeit besonders beschäftigt – und warum?

Sie werden gebeten **5 reale Patient:innenfälle** aus Ihrer Praxis auszuwählen.

Bitte starten Sie die Dokumentation mithilfe des bereitgestellten Fragebogens mit denjenigen Patient:innen, die **≥ 2 Exazerbationen innerhalb von 12 Monaten** aufweisen (anonymisiert).

Für den Fall, dass Ihnen keine 5 Patient:innen mit **≥ 2 Exazerbationen innerhalb von 12 Monaten** zur Auswahl stehen, wählen Sie bitte Patient:innen mit Bronchiectasen-Erkrankung und weniger Exazerbationen aus.

Diese Fälle dienen als Grundlage für die **strukturierte Gruppenarbeit** im bevorstehenden **Expertenforum zur Bronchiectasen-Erkrankung**.

Die Auswertung der Fälle soll es ermöglichen, **typische Behandlungsmuster, Unterschiede und Herausforderungen** in der Versorgung von Patient:innen mit Bronchiectasen-Erkrankung zu erkennen.

Bitte tragen Sie hier Ihren Titel, Vornamen und Namen ein:



Patientenfall 1

1. Patientencharakteristika

☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers Alter:

Symptomatik:

☐ Husten ☐ Fieber ☐ Fatigue ☐ Hämoptysen
☐ Auswurf ☐ Dyspnoe ☐ Thoraxschmerzen

Klinische Schwere der Symptome (Ihre Einschätzung):

☐ Leicht ☐ Mittel ☐ Schwer

Wichtige Komorbiditäten (Mehrfachauswahl möglich):

☐ COPD ☐ Asthma ☐ NTM ☐ Andere:

FEV₁-Bereich:

☐ ≥ 80 % ☐ 50 – 79 % ☐ < 50 %

2. Das letzte Jahr auf einen Blick

Exazerbationen (vergangene 12 Monate):

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥ 3

Hospitalisierungen (vergangene 12 Monate):

☐ 0 ☐ 1 ☐ ≥ 2

3. Aktuelles Vorgehen

Basistherapie

☐ Rauchstopp ☐ Rehabilitation
☐ Schutzimpfungen ☐ Optimierung des Selbstmanagements
☐ Physiotherapeutische Atemtherapie ☐ Andere
☐ Sekretolytische Therapie
☐ Verneblerschulung

Akuttherapie post Exazerbation

☐ Langzeittherapie mit Antibiotika (oral/inhalativ) ☐ Lungentransplantation
☐ Antiinflammatorische Langzeittherapie ☐ Andere
☐ Thoraxchirurgie
☐ Nichtinvasive Beatmung bei chronischer ventilatorischer Insuffizienz

Zusätzliche Therapien

☐ Bronchodilatoren bei klinisch relevanter Dyspnoe und/oder obstruktiver Ventilationsstörung und/oder Überblähung (LABA/LAMA)
☐ ICS (ohne Indikation durch Ätiologie o. Komorbidität)
☐ Mukoaktive Langzeittherapie als Adjuvantien der Atemphysiotherapie
☐ Andere

Patientenfall 2

1. Patientencharakteristika

☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers Alter:

Symptomatik:

Husten Fieber Fatigue Hämoptysen
Auswurf Dyspnoe Thoraxschmerzen

Klinische Schwere der Symptome (Ihre Einschätzung):

☐ Leicht ☐ Mittel ☐ Schwer

Wichtige Komorbiditäten (Mehrfachauswahl möglich):

☐ COPD ☐ Asthma ☐ NTM ☐ Andere:

FEV₁-Bereich:

☐ ≥ 80 % ☐ 50 – 79 % ☐ < 50 %

2. Das letzte Jahr auf einen Blick

Exazerbationen (vergangene 12 Monate):

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥ 3

Hospitalisierungen (vergangene 12 Monate):

☐ 0 ☐ 1 ☐ ≥ 2

3. Aktuelles Vorgehen

Basistherapie

Rauchstopp Rehabilitation
Schutzimpfungen Optimierung des Selbstmanagements
Physiotherapeutische Atemtherapie Andere
Sekretolytische Therapie
Verneblerschulung

Akuttherapie post Exazerbation

Langzeittherapie mit Antibiotika Lungentransplantation
(oral/inhalativ) Andere
Antiinflammatorische Langzeittherapie
Thoraxchirurgie
Nichtinvasive Beatmung bei chronischer ventilatorischer Insuffizienz

Zusätzliche Therapien

Bronchodilatoren bei klinisch relevanter Dyspnoe und/oder obstruktiver Ventilationsstörung und/oder Überblähung (LABA/LAMA)
ICS (ohne Indikation durch Ätiologie o. Komorbidität)
Mukoaktive Langzeittherapie als Adjuvantien der Atemphysiotherapie
Andere

Patientenfall 3

1. Patientencharakteristika

☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers Alter:

Symptomatik:

Husten Fieber Fatigue Hämoptysen
Auswurf Dyspnoe Thoraxschmerzen

Klinische Schwere der Symptome (Ihre Einschätzung):

☐ Leicht ☐ Mittel ☐ Schwer

Wichtige Komorbiditäten (Mehrfachauswahl möglich):

☐ COPD ☐ Asthma ☐ NTM ☐ Andere:

FEV₁-Bereich:

☐ ≥ 80 % ☐ 50 – 79 % ☐ < 50 %

2. Das letzte Jahr auf einen Blick

Exazerbationen (vergangene 12 Monate):

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥ 3

Hospitalisierungen (vergangene 12 Monate):

☐ 0 ☐ 1 ☐ ≥ 2

3. Aktuelles Vorgehen

Basistherapie

Rauchstopp Rehabilitation
Schutzimpfungen Optimierung des Selbstmanagements
Physiotherapeutische Atemtherapie Andere
Sekretolytische Therapie
Verneblerschulung

Akuttherapie post Exazerbation

Langzeittherapie mit Antibiotika Lungentransplantation
(oral/inhalativ) Andere
Antiinflammatorische Langzeittherapie
Thoraxchirurgie
Nichtinvasive Beatmung bei chronischer ventilatorischer Insuffizienz

Zusätzliche Therapien

Bronchodilatoren bei klinisch relevanter Dyspnoe und/oder obstruktiver Ventilationsstörung und/oder Überblähung (LABA/LAMA)
ICS (ohne Indikation durch Ätiologie o. Komorbidität)
Mukoaktive Langzeittherapie als Adjuvantien der Atemphysiotherapie
Andere

Patientenfall 4

1. Patientencharakteristika

☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers Alter:

Symptomatik:

Husten Fieber Fatigue Hämoptysen
Auswurf Dyspnoe Thoraxschmerzen

Klinische Schwere der Symptome (Ihre Einschätzung):

☐ Leicht ☐ Mittel ☐ Schwer

Wichtige Komorbiditäten (Mehrfachauswahl möglich):

☐ COPD ☐ Asthma ☐ NTM ☐ Andere:

FEV₁-Bereich:

☐ ≥ 80 % ☐ 50 – 79 % ☐ < 50 %

2. Das letzte Jahr auf einen Blick

Exazerbationen (vergangene 12 Monate):

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥ 3

Hospitalisierungen (vergangene 12 Monate):

☐ 0 ☐ 1 ☐ ≥ 2

3. Aktuelles Vorgehen

Basistherapie

Rauchstopp Rehabilitation
Schutzimpfungen Optimierung des Selbstmanagements
Physiotherapeutische Atemtherapie Andere
Sekretolytische Therapie
Verneblerschulung

Akuttherapie post Exazerbation

Langzeittherapie mit Antibiotika Lungentransplantation
(oral/inhalativ) Andere
Antiinflammatorische Langzeittherapie
Thoraxchirurgie
Nichtinvasive Beatmung bei chronischer ventilatorischer Insuffizienz

Zusätzliche Therapien

Bronchodilatoren bei klinisch relevanter Dyspnoe und/oder obstruktiver Ventilationsstörung und/oder Überblähung (LABA/LAMA)
ICS (ohne Indikation durch Ätiologie o. Komorbidität)
Mukoaktive Langzeittherapie als Adjuvantien der Atemphysiotherapie
Andere

Patientenfall 5

1. Patientencharakteristika

männlich weiblich divers Alter:

Symptomatik:

Husten Fieber Fatigue Hämoptysen
Auswurf Dyspnoe Thoraxschmerzen

Klinische Schwere der Symptome (Ihre Einschätzung):

Leicht Mittel Schwer

Wichtige Komorbiditäten (Mehrfachauswahl möglich):

COPD Asthma NTM Andere:

FEV₁-Bereich:

≥ 80 % 50 – 79 % < 50 %

2. Das letzte Jahr auf einen Blick

Exazerbationen (vergangene 12 Monate):

0 1 2 ≥ 3

Hospitalisierungen (vergangene 12 Monate):

0 1 ≥ 2

3. Aktuelles Vorgehen

Basistherapie

Rauchstopp Rehabilitation
Schutzimpfungen Optimierung des Selbstmanagements
Physiotherapeutische Atemtherapie Andere
Sekretolytische Therapie
Verneblerschulung

Akuttherapie post Exazerbation

Langzeittherapie mit Antibiotika Lungentransplantation
(oral/inhalativ) Andere
Antiinflammatorische Langzeittherapie
Thoraxchirurgie
Nichtinvasive Beatmung bei chronischer ventilatorischer Insuffizienz

Zusätzliche Therapien

Bronchodilatoren bei klinisch relevanter Dyspnoe und/oder obstruktiver Ventilationsstörung und/oder Überblähung (LABA/LAMA)
ICS (ohne Indikation durch Ätiologie o. Komorbidität)
Mukoaktive Langzeittherapie als Adjuvantien der Atemphysiotherapie
Andere